

OLA VET • 2026

RESUMOS VISUAIS

VETERINÁRIA

100 páginas para conectar sinais, exames e decisões



Cães e gatos • Fundamentos • Hematologia • Farmacologia • Clínica •
Urgências

Material educativo para estudantes e profissionais

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA

PK acompanha o destino do fármaco; PD relaciona concentração e efeito.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Absorção, distribuição, metabolismo e excreção compõem o percurso ADME.

02

NA PRÁTICA

O mesmo efeito pode mudar com a exposição, o receptor e o estado do paciente.

ATENÇÃO CLÍNICA

Via, espécie e função renal ou hepática alteram a resposta.

ABSORÇÃO E BIODISPONIBILIDADE

A quantidade que chega à circulação depende da via e da formulação.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Via intravenosa entrega o fármaco diretamente à circulação sistêmica.

02

NA PRÁTICA

Via oral envolve dissolução, absorção e possível metabolismo de primeira passagem.

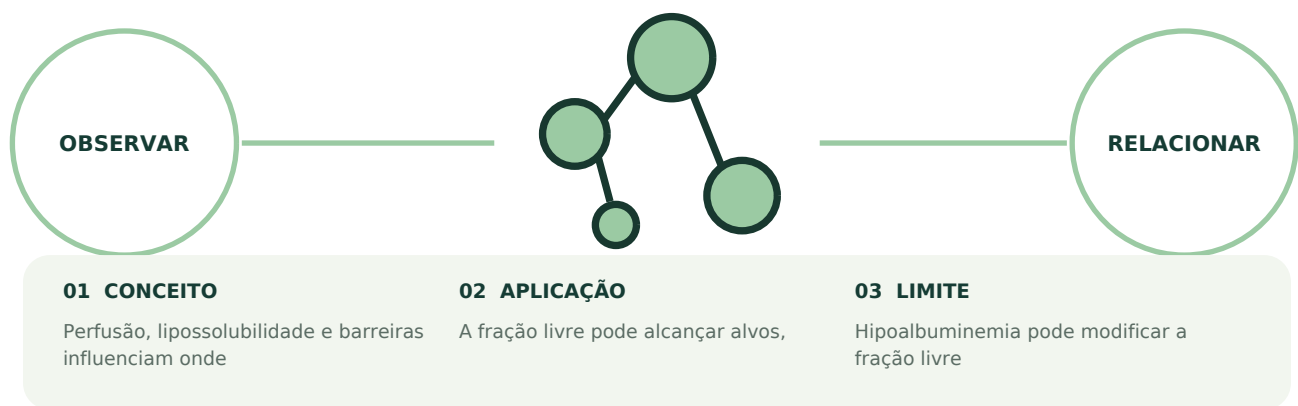
ATENÇÃO CLÍNICA

Não equipare automaticamente doses por vias diferentes.

DISTRIBUIÇÃO E PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

Depois de entrar no sangue, o fármaco se reparte entre plasma e tecidos.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Perfusão, lipossolubilidade e barreiras influenciam onde ele chega.

02

NA PRÁTICA

A fração livre pode alcançar alvos, ser eliminada e produzir efeitos.

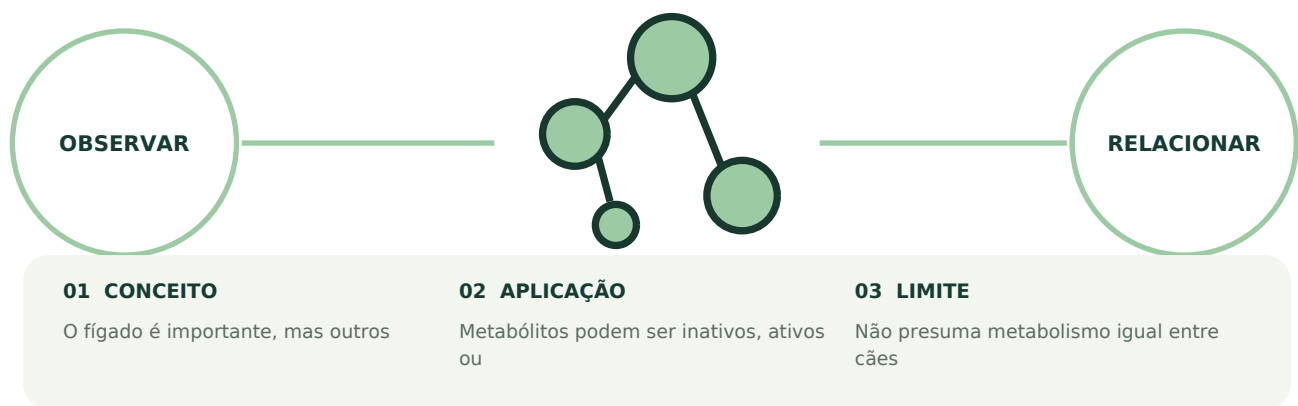
ATENÇÃO CLÍNICA

Hipoalbuminemia pode modificar a fração livre de alguns fármacos.

METABOLISMO E BIOTRANSFORMAÇÃO

O organismo transforma muitas moléculas antes de eliminá-las.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

O fígado é importante, mas outros tecidos também metabolizam fármacos.

02

NA PRÁTICA

Metabólitos podem ser inativos, ativos ou potencialmente tóxicos.

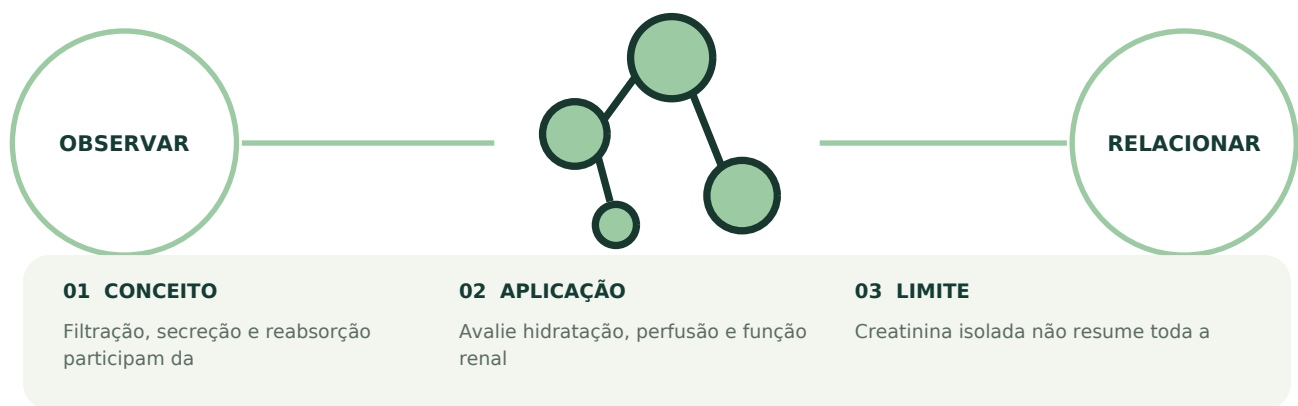
ATENÇÃO CLÍNICA

Não presuma metabolismo igual entre cães e gatos.

EXCREÇÃO E FUNÇÃO RENAL

Eliminação depende do fármaco e da integridade dos órgãos excretores.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Filtração, secreção e reabsorção participam da eliminação renal.

02

NA PRÁTICA

Avalie hidratação, perfusão e função renal quando o fármaco depende do rim.

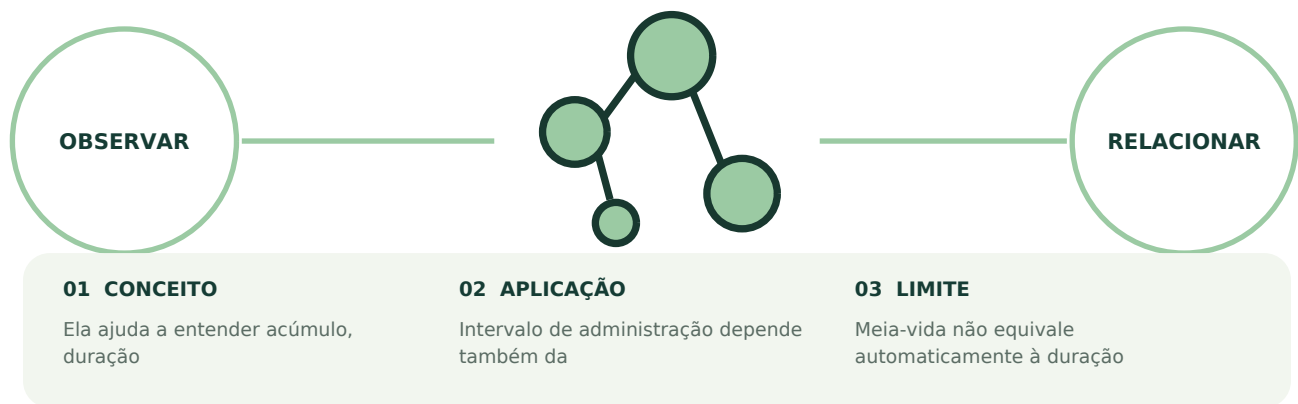
ATENÇÃO CLÍNICA

Creatinina isolada não resume toda a função renal.

MEIA-VIDA E INTERVALO

A meia-vida descreve o tempo de queda da concentração plasmática pela metade.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Ela ajuda a entender acúmulo, duração e tempo até equilíbrio.

02

NA PRÁTICA

Intervalo de administração depende também da relação entre concentração e efeito.

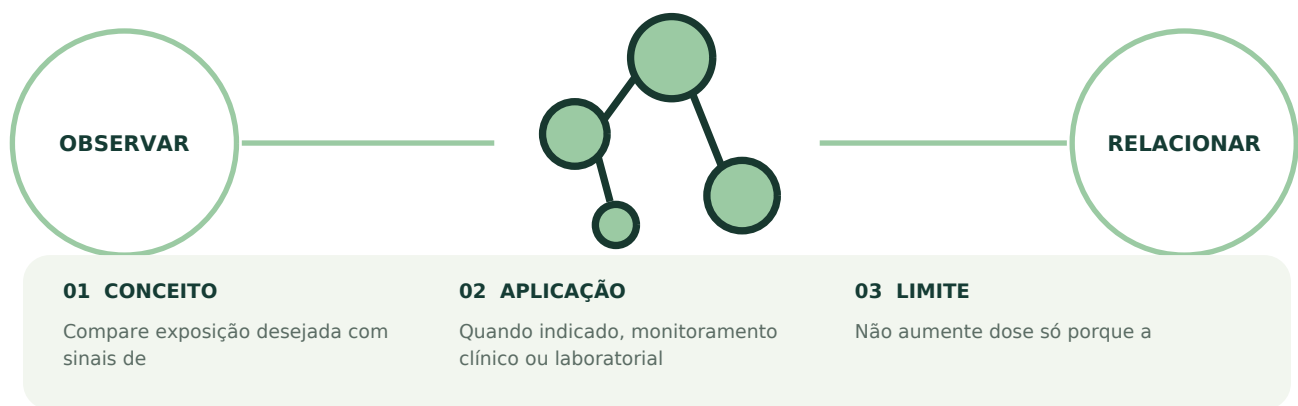
ATENÇÃO CLÍNICA

Meia-vida não equivale automaticamente à duração clínica.

MARGEM TERAPÊUTICA

Benefício e toxicidade podem estar próximos para alguns medicamentos.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Compare exposição desejada com sinais de reação adversa.

02

NA PRÁTICA

Quando indicado, monitoramento clínico ou laboratorial melhora a segurança.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não aumente dose só porque a resposta inicial parece discreta.

AGONISTAS E ANTAGONISTAS

Receptores traduzem a presença do fármaco em uma resposta biológica.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Agonista ativa o receptor; antagonista impede ou reduz a ativação.

02

NA PRÁTICA

Potência e eficácia descrevem aspectos diferentes da resposta.

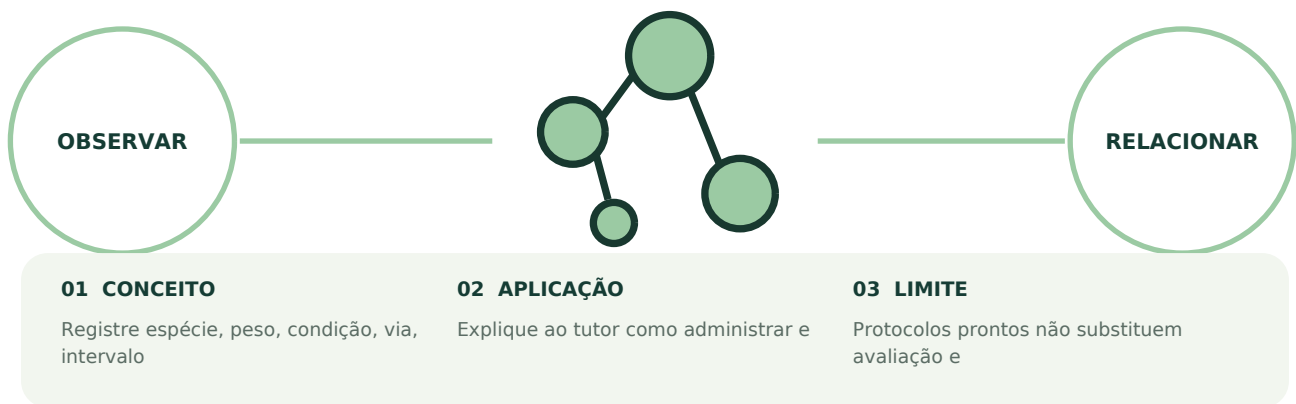
ATENÇÃO CLÍNICA

Mais potente não significa necessariamente mais eficaz.

PRESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

Toda prescrição começa com paciente, objetivo e reavaliação definidos.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Registre espécie, peso, condição, via, intervalo e duração.

02

NA PRÁTICA

Explique ao tutor como administrar e quais sinais exigem contato.

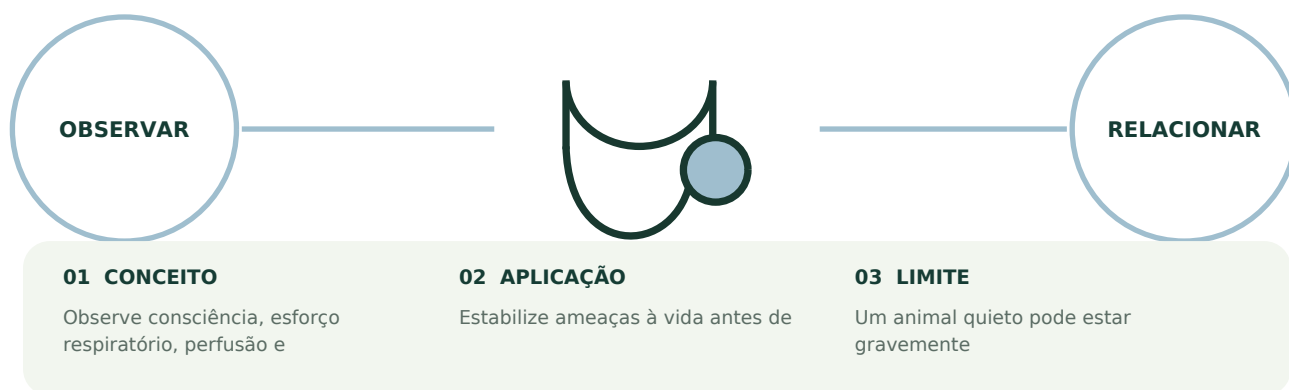
ATENÇÃO CLÍNICA

Protocolos prontos não substituem avaliação e bula vigente.

TRIAGEM E PRIORIDADE

O primeiro exame identifica riscos imediatos antes de aprofundar a investigação.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Observe consciência, esforço respiratório, perfusão e sangramento.

02

NA PRÁTICA

Estabilize ameaças à vida antes de exames que possam esperar.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um animal quieto pode estar gravemente comprometido.

ANAMNESE ORIENTADA

Uma boa história transforma uma queixa ampla em hipóteses testáveis.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Registre início, evolução, ambiente, dieta, medicamentos

02 APLICAÇÃO

Pergunte o que mudou na rotina

03 LIMITE

Evite fechar diagnóstico apenas pela descrição

01

ENTENDA

Registre início, evolução, ambiente, dieta, medicamentos e exposição.

02

NA PRÁTICA

Pergunte o que mudou na rotina e o que o tutor já tentou.

ATENÇÃO CLÍNICA

Evite fechar diagnóstico apenas pela descrição inicial.

EXAME FÍSICO SISTEMÁTICO

A sequência fixa reduz achados esquecidos durante a consulta.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Avalie atitude, mucosas, hidratação, auscultação e

02 APLICAÇÃO

Compare achados com idade, espécie e

03 LIMITE

Exame normal em um momento não

01

ENTENDA

Avalie atitude, mucosas, hidratação, auscultação e palpação.

02

NA PRÁTICA

Compare achados com idade, espécie e contexto do paciente.

ATENÇÃO CLÍNICA

Exame normal em um momento não exclui doença dinâmica.

MUCOSAS E PERFUSÃO

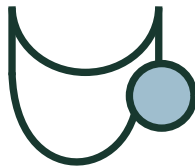
Cor e umidade das mucosas ajudam a avaliar circulação e oxigenação.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Mucosa pálida pode acompanhar anemia ou



02 APLICAÇÃO

Associe com pulsos, frequência, temperatura e

RELACIONAR

03 LIMITE

Cor isolada não define a causa

01

ENTENDA

Mucosa pálida pode acompanhar anemia ou hipoperfusão.

02

NA PRÁTICA

Associe com pulsos, frequência, temperatura e tempo de reperfusão.

ATENÇÃO CLÍNICA

Cor isolada não define a causa.

FREQUÊNCIA CARDÍACA E PULSO

Frequência, ritmo e qualidade do pulso oferecem pistas diferentes.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Compare pulso palpável com batimentos auscultados

02 APLICAÇÃO

Déficit de pulso pode indicar batimentos

03 LIMITE

Estresse e dor também alteram a

01

ENTENDA

Compare pulso palpável com batimentos auscultados.

02

NA PRÁTICA

Déficit de pulso pode indicar batimentos sem ejeção efetiva.

ATENÇÃO CLÍNICA

Estresse e dor também alteram a frequência.

PADRÃO RESPIRATÓRIO

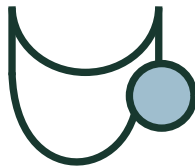
Esforço e postura podem ser mais urgentes que um número isolado.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Observe frequência, amplitude, ruídos e uso



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Mínima manipulação é útil quando há

03 LIMITE

Não force decúbito em paciente que

01

ENTENDA

Observe frequência, amplitude, ruídos e uso abdominal.

02

NA PRÁTICA

Mínima manipulação é útil quando há sofrimento respiratório.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não force decúbito em paciente que procura posição para respirar.

HIDRATAÇÃO VERSUS VOLEMIA

Desidratação e hipovolemia não são sinônimos.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Perda de água corporal pode aparecer

02 APLICAÇÃO

Hipovolemia se manifesta sobretudo por perfusão

03 LIMITE

Turgor cutâneo varia com idade e

01

ENTENDA

Perda de água corporal pode aparecer em mucosas e turgor.

02

NA PRÁTICA

Hipovolemia se manifesta sobretudo por perfusão inadequada.

ATENÇÃO CLÍNICA

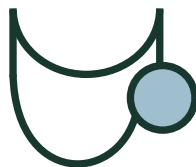
Turgor cutâneo varia com idade e condição corporal.

ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL

O escore traduz reservas de gordura melhor que o peso isolado.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Observe cintura, contorno abdominal e palpação

02 APLICAÇÃO

Associe peso seriado e escore para

03 LIMITE

Pelagem e massa muscular podem mascarar

01

ENTENDA

Observe cintura, contorno abdominal e palpação das costelas.

02

NA PRÁTICA

Associe peso seriado e escore para acompanhar tendência.

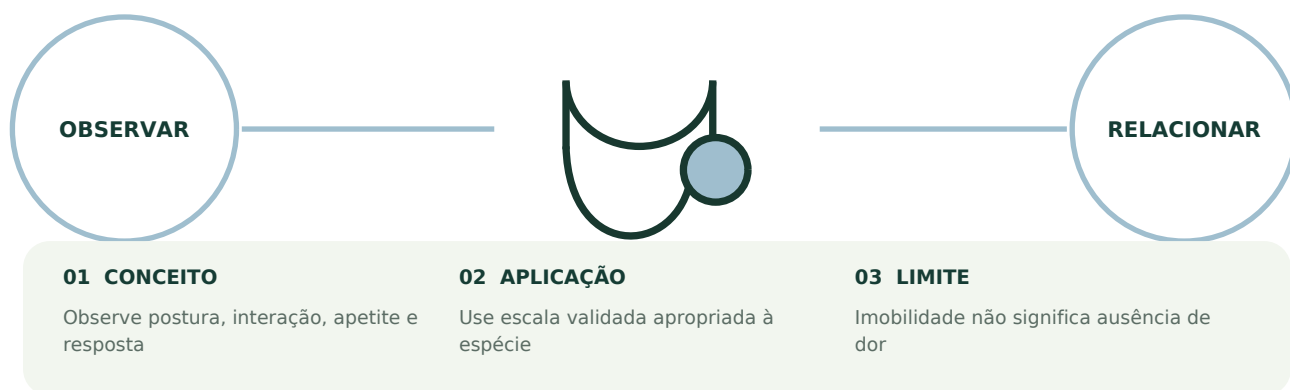
ATENÇÃO CLÍNICA

Pelagem e massa muscular podem mascarar o aspecto.

AVALIAÇÃO DE DOR

Dor deve ser procurada e reavaliada de maneira estruturada.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Observe postura, interação, apetite e resposta ao toque.

02

NA PRÁTICA

Use escala validada apropriada à espécie e ao contexto.

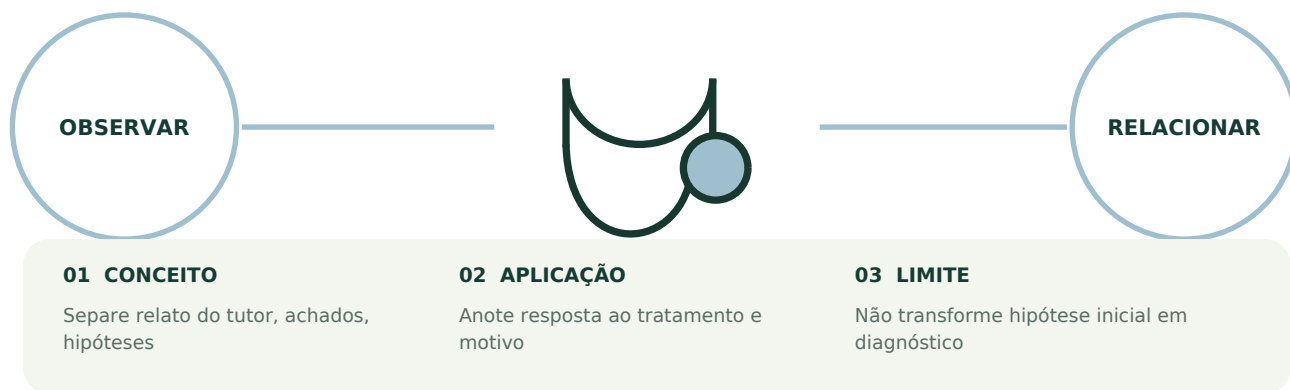
ATENÇÃO CLÍNICA

Imobilidade não significa ausência de dor.

REGISTRO CLÍNICO CLARO

Um prontuário útil mostra o raciocínio e permite continuidade do cuidado.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Separe relato do tutor, achados, hipóteses e plano.

02

NA PRÁTICA

Anote resposta ao tratamento e motivo das mudanças.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não transforme hipótese inicial em diagnóstico definitivo.

HEMOGRAMA EM TRÊS BLOCOS

Leia série vermelha, série branca e plaquetas em conjunto.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Conecte números a esfregaço, clínica e

02 APLICAÇÃO

Tendências em exames seriados podem valer

03 LIMITE

Intervalos de referência variam por laboratório

RELACIONAR

01

ENTENDA

Conecte números a esfregaço, clínica e método de coleta.

02

NA PRÁTICA

Tendências em exames seriados podem valer mais que um resultado.

ATENÇÃO CLÍNICA

Intervalos de referência variam por laboratório e espécie.

HEMATÓCRITO E HEMOGLOBINA

Ambos ajudam a reconhecer alterações da massa eritrocitária.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

RELACIONAR

01 CONCEITO

Hematócrito estima a fração do sangue

02 APLICAÇÃO

Desidratação pode concentrar o sangue e

03 LIMITE

Um valor normal pode ocultar perda

01

ENTENDA

Hematócrito estima a fração do sangue ocupada por eritrócitos.

02

NA PRÁTICA

Desidratação pode concentrar o sangue e confundir a leitura.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um valor normal pode ocultar perda sanguínea muito recente.

ANEMIA REGENERATIVA

Reticulócitos ajudam a estimar resposta da medula à anemia.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Regeneração sugere que há produção compensatória

02 APLICAÇÃO

Investigue perda sanguínea e hemólise conforme

03 LIMITE

O tempo desde o início da

RELACIONAR

01

ENTENDA

Regeneração sugere que há produção compensatória de eritrócitos.

02

NA PRÁTICA

Investigue perda sanguínea e hemólise conforme os demais achados.

ATENÇÃO CLÍNICA

O tempo desde o início da anemia importa.

ANEMIA NÃO REGENERATIVA

Resposta medular inadequada muda a lista de hipóteses.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Considere doença crônica, deficiência, rim e

02 APLICAÇÃO

Relacione reticulócitos ao grau de anemia,

RELACIONAR

03 LIMITE

Uma anemia aguda pode ainda não

01

ENTENDA

Considere doença crônica, deficiência, rim e doença da medula.

02

NA PRÁTICA

Relacione reticulócitos ao grau de anemia, não só ao valor bruto.

ATENÇÃO CLÍNICA

Uma anemia aguda pode ainda não mostrar regeneração.

ÍNDICES ERITROCITÁRIOS

VCM e CHCM descrevem tamanho celular e concentração de hemoglobina.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Padrões microcíticos ou macrocíticos ajudam a

02 APLICAÇÃO

Confirme mudanças importantes no esfregaço

03 LIMITE

Artefatos de amostra podem distorcer índices

01

ENTENDA

Padrões microcíticos ou macrocíticos ajudam a organizar hipóteses.

02

NA PRÁTICA

Confirme mudanças importantes no esfregaço.

ATENÇÃO CLÍNICA

Artefatos de amostra podem distorcer índices.

MORFOLOGIA ERITROCITÁRIA

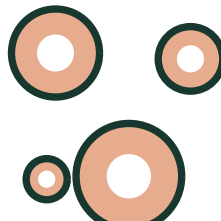
O esfregaço acrescenta informação que o contador não mostra.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Observe tamanho, forma, cor e inclusões



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Esferócitos e esquizócitos têm interpretações distintas

03 LIMITE

Um achado morfológico não fecha sozinho

01

ENTENDA

Observe tamanho, forma, cor e inclusões dos eritrócitos.

02

NA PRÁTICA

Esferócitos e esquizócitos têm interpretações distintas.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um achado morfológico não fecha sozinho um diagnóstico.

LEUCOGRAMA: NÚMEROS ABSOLUTOS

A porcentagem de leucócitos pode enganar quando o total muda.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

RELACIONAR

01 CONCEITO

Calcule ou confira contagens absolutas por

02 APLICAÇÃO

Interprete neutrófilos, linfócitos e monócitos no

03 LIMITE

Não chame de linfocitose apenas uma

01

ENTENDA

Calcule ou confira contagens absolutas por população.

02

NA PRÁTICA

Interprete neutrófilos, linfócitos e monócitos no contexto.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não chame de linfocitose apenas uma porcentagem alta.

DESVIO À ESQUERDA

Neutrófilos imaturos indicam resposta medular à demanda.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Combine desvio com toxicidade celular e

02 APLICAÇÃO

A intensidade da inflamação não acompanha

03 LIMITE

Leucopenia com desvio pode ser um

RELACIONAR

01

ENTENDA

Combine desvio com toxicidade celular e número total.

02

NA PRÁTICA

A intensidade da inflamação não acompanha sempre a leucocitose.

ATENÇÃO CLÍNICA

Leucopenia com desvio pode ser um achado grave.

LEUCOGRAMA DE ESTRESSE

Glicocorticoides endógenos ou exógenos alteram a distribuição celular.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Neutrofilia madura e linfopenia são padrões

02 APLICAÇÃO

Compare com história de medicação e

03 LIMITE

Padrões podem coexistir com inflamação

01

ENTENDA

Neutrofilia madura e linfopenia são padrões possíveis.

02

NA PRÁTICA

Compare com história de medicação e quadro clínico.

ATENÇÃO CLÍNICA

Padrões podem coexistir com inflamação.

PLAQUETAS E AGREGADOS

Baixa contagem automática deve ser conferida no esfregaço.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Gatos frequentemente apresentam agregados plaquetários na

02 APLICAÇÃO

Considere sangramento clínico e estimativa manual

03 LIMITE

Não diagnostique trombocitopenia sem excluir agregação

01

ENTENDA

Gatos frequentemente apresentam agregados plaquetários na coleta.

02

NA PRÁTICA

Considere sangramento clínico e estimativa manual.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não diagnostique trombocitopenia sem excluir agregação.

HEMOSTASIA PRIMÁRIA

Plaquetas e vasos participam da formação inicial do tampão.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Petéquias e sangramento mucoso orientam a

02 APLICAÇÃO

Revise contagem plaquetária e história de

03 LIMITE

Uma contagem normal não prova função

01

ENTENDA

Petéquias e sangramento mucoso orientam a investigação.

02

NA PRÁTICA

Revise contagem plaquetária e história de fármacos.

ATENÇÃO CLÍNICA

Uma contagem normal não prova função plaquetária normal.

HEMOSTASIA SECUNDÁRIA

A cascata de coagulação estabiliza o coágulo de fibrina.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Hematomas profundos e sangramento tardio são

02 APLICAÇÃO

Tempo de protrombina e tempo de

03 LIMITE

Interprete junto do quadro e da

RELACIONAR

01

ENTENDA

Hematomas profundos e sangramento tardio são pistas possíveis.

02

NA PRÁTICA

Tempo de protrombina e tempo de tromboplastina avaliam vias distintas.

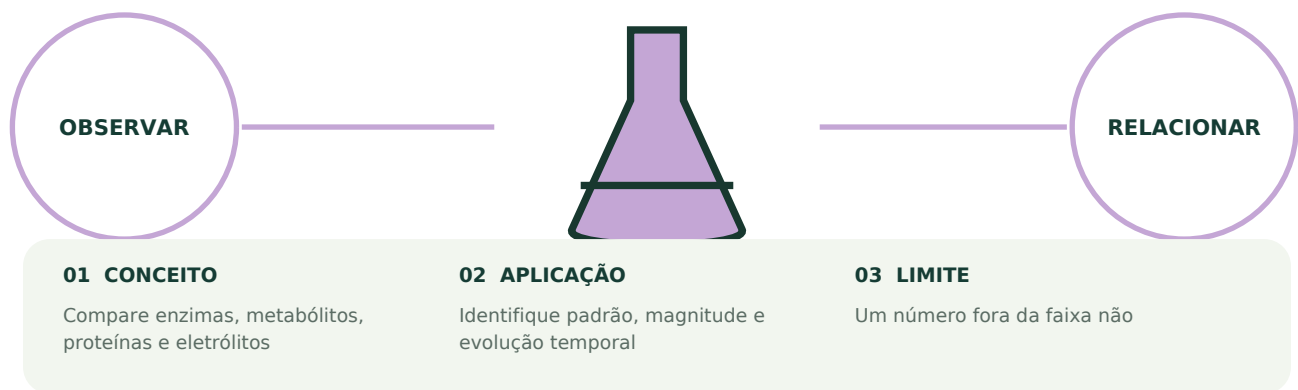
ATENÇÃO CLÍNICA

Interprete junto do quadro e da qualidade da amostra.

BIOQUÍMICA POR PADRÕES

Um analito alterado ganha sentido quando lido em conjunto.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Compare enzimas, metabólitos, proteínas e eletrólitos.

02

NA PRÁTICA

Identifique padrão, magnitude e evolução temporal.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um número fora da faixa não equivale a diagnóstico.

UREIA E CREATININA

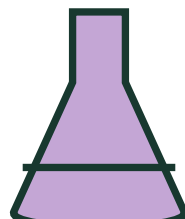
Azotemia precisa ser situada em perfusão, rim e trato urinário.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Desidratação e baixa perfusão podem elevar



02 APLICAÇÃO

Densidade urinária ajuda a interpretar concentração

RELACIONAR

03 LIMITE

Não classifique doença renal com uma

01

ENTENDA

Desidratação e baixa perfusão podem elevar os valores.

02

NA PRÁTICA

Densidade urinária ajuda a interpretar concentração renal.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não classifique doença renal com uma medida isolada.

ALT E LESÃO HEPATOCELULAR

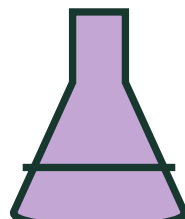
ALT sugere lesão de hepatócitos, especialmente em cães e gatos.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Magnitude e persistência orientam investigação adicional



02 APLICAÇÃO

Associe enzimas a bilirrubina, função e

RELACIONAR

03 LIMITE

ALT alta não mede diretamente capacidade

01

ENTENDA

Magnitude e persistência orientam investigação adicional.

02

NA PRÁTICA

Associe enzimas a bilirrubina, função e imagem.

ATENÇÃO CLÍNICA

ALT alta não mede diretamente capacidade funcional do fígado.

FA E COLESTASE

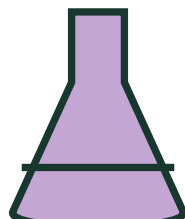
Fosfatase alcalina pode elevar por indução ou colestase.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Compare com GGT, bilirrubina, sinais e



02 APLICAÇÃO

Idade e espécie modificam a interpretação

RELACIONAR

03 LIMITE

Não atribua qualquer elevação a obstrução

01

ENTENDA

Compare com GGT, bilirrubina, sinais e histórico de fármacos.

02

NA PRÁTICA

Idade e espécie modificam a interpretação.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não atribua qualquer elevação a obstrução biliar.

ALBUMINA E PROTEÍNAS

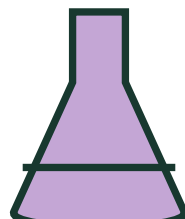
Albumina informa sobre produção, perda e distribuição.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Hipoalbuminemia pede avaliação de fígado, rim,



02 APLICAÇÃO

Compare globulinas e proteína total

RELACIONAR

03 LIMITE

Fluidoterapia pode alterar concentração medida

01

ENTENDA

Hipoalbuminemia pede avaliação de fígado, rim, intestino e inflamação.

02

NA PRÁTICA

Compare globulinas e proteína total.

ATENÇÃO CLÍNICA

Fluidoterapia pode alterar concentração medida.

GLICOSE E CONTEXTO

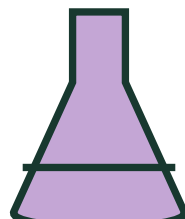
A glicemia reflete alimentação, estresse e controle metabólico.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Gatos podem apresentar hiperglicemia de estresse



02 APLICAÇÃO

Confirme achados persistentes e considere urina

RELACIONAR

03 LIMITE

Um valor isolado não diagnostica diabetes

01

ENTENDA

Gatos podem apresentar hiperglicemia de estresse.

02

NA PRÁTICA

Confirme achados persistentes e considere urina e sinais clínicos.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um valor isolado não diagnostica diabetes.

ELETRÓLITOS

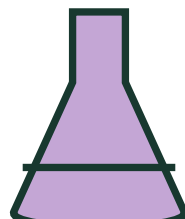
Sódio, potássio e cloro importam para função celular e cardíaca.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Observe direção, velocidade e contexto da



02 APLICAÇÃO

Reavalie depois de intervenções e fluidos

RELACIONAR

03 LIMITE

Hemólise pode interferir especialmente no potássio

01

ENTENDA

Observe direção, velocidade e contexto da alteração.

02

NA PRÁTICA

Reavalie depois de intervenções e fluidos.

ATENÇÃO CLÍNICA

Hemólise pode interferir especialmente no potássio.

DENSIDADE URINÁRIA

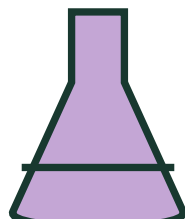
A densidade mostra a capacidade de concentrar urina naquele momento.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Leia junto do estado de hidratação



02 APLICAÇÃO

Use refratômetro adequado à amostra veterinária

RELACIONAR

03 LIMITE

Dieta, fluidos e diuréticos podem mudar

01

ENTENDA

Leia junto do estado de hidratação e da azotemia.

02

NA PRÁTICA

Use refratômetro adequado à amostra veterinária.

ATENÇÃO CLÍNICA

Dieta, fluidos e diuréticos podem mudar o resultado.

SEDIMENTO URINÁRIO

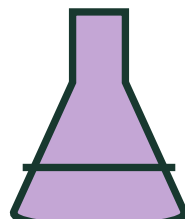
Microscopia revela células, cilindros, cristais e microrganismos.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Amostra fresca e método de coleta



02 APLICAÇÃO

Cristais pedem correlação com pH, sinais

RELACIONAR

03 LIMITE

Cristalúria sozinha não comprova cálculo

01

ENTENDA

Amostra fresca e método de coleta melhoram interpretação.

02

NA PRÁTICA

Cristais pedem correlação com pH, sinais e imagem.

ATENÇÃO CLÍNICA

Cristalúria sozinha não comprova cálculo.

PROTEINÚRIA

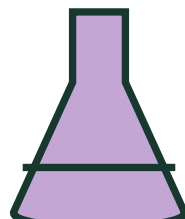
Proteína persistente requer confirmação e localização da origem.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Descartar inflamação ou hemorragia urinária é



02 APLICAÇÃO

Relação proteína:creatinina pode ajudar na quantificação

RELACIONAR

03 LIMITE

Uma fita positiva não define proteinúria

01

ENTENDA

Descartar inflamação ou hemorragia urinária é parte do processo.

02

NA PRÁTICA

Relação proteína:creatinina pode ajudar na quantificação.

ATENÇÃO CLÍNICA

Uma fita positiva não define proteinúria renal.

COLETA PARA CULTURA

O resultado microbiológico depende da origem e da coleta.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Identifique local, método, antibiótico prévio e



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Colete antes de iniciar antimicrobiano quando

03 LIMITE

Swab superficial pode representar colonização

01

ENTENDA

Identifique local, método, antibiótico prévio e horário.

02

NA PRÁTICA

Colete antes de iniciar antimicrobiano quando isso for viável.

ATENÇÃO CLÍNICA

Swab superficial pode representar colonização.

COLONIZAÇÃO VERSUS INFECÇÃO

Presença de microrganismos não implica doença ativa.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Correlacione cultura com sinais, citologia e



02 APLICAÇÃO

Amostras de sítios estéreis exigem interpretação

RELACIONAR

03 LIMITE

Tratar toda cultura positiva favorece uso

01

ENTENDA

Correlacione cultura com sinais, citologia e inflamação.

02

NA PRÁTICA

Amostras de sítios estéreis exigem interpretação distinta.

ATENÇÃO CLÍNICA

Tratar toda cultura positiva favorece uso inadequado.

ANTIBIOGRAMA

Sensibilidade em laboratório orienta, mas não resolve tudo.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Considere espécie bacteriana, local, exposição e



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Escolha espectro apropriado ao diagnóstico estabelecido

03 LIMITE

Resultado sensível não garante concentração no

01

ENTENDA

Considere espécie bacteriana, local, exposição e perfusão.

02

NA PRÁTICA

Escolha espectro apropriado ao diagnóstico estabelecido.

ATENÇÃO CLÍNICA

Resultado sensível não garante concentração no tecido.

USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS

Antimicrobianos precisam de indicação, escolha e revisão.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Procure evidência de infecção bacteriana antes



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Reavalie resposta e ajuste com cultura

03 LIMITE

Infecção viral ou inflamação estéril não

01

ENTENDA

Procure evidência de infecção bacteriana antes da prescrição.

02

NA PRÁTICA

Reavalie resposta e ajuste com cultura quando indicado.

ATENÇÃO CLÍNICA

Infecção viral ou inflamação estéril não pede antibiótico.

CITOLOGIA DE PELE

Citologia aproxima a lesão visível de seu componente celular.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Procure bactérias, leveduras e padrão inflamatório



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Amostre lesões representativas antes de limpar

03 LIMITE

Uma lâmina ruim pode ocultar o

01

ENTENDA

Procure bactérias, leveduras e padrão inflamatório.

02

NA PRÁTICA

Amostre lesões representativas antes de limpar a superfície.

ATENÇÃO CLÍNICA

Uma lâmina ruim pode ocultar o agente.

CITOLOGIA DE OUVIDO

Otite exige identificar causas primárias e alterações secundárias.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Otoscopia e citologia orientam a investigação



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Compare material de cada ouvido e

03 LIMITE

Tratamento repetido sem investigar causa favorece

01

ENTENDA

Otoscopia e citologia orientam a investigação inicial.

02

NA PRÁTICA

Compare material de cada ouvido e reavalie a resposta.

ATENÇÃO CLÍNICA

Tratamento repetido sem investigar causa favorece recidiva.

PIODERMITE SUPERFICIAL

Pápulas, pústulas e colaretes epidérmicos sugerem o padrão.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Citologia ajuda a apoiar infecção bacteriana



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Busque alergias e outras causas subjacentes

03 LIMITE

Lesões parecidas podem ter causas diferentes

01

ENTENDA

Citologia ajuda a apoiar infecção bacteriana.

02

NA PRÁTICA

Busque alergias e outras causas subjacentes.

ATENÇÃO CLÍNICA

Lesões parecidas podem ter causas diferentes.

DERMATOFITOSE

Fungos dermatófitos podem envolver pelos e pele e ter importância zoonótica.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Combine exposição, lesões e testes apropriados



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Manejo do ambiente e dos contatos

03 LIMITE

A aparência circular clássica não está

01

ENTENDA

Combine exposição, lesões e testes apropriados.

02

NA PRÁTICA

Manejo do ambiente e dos contatos pode ser necessário.

ATENÇÃO CLÍNICA

A aparência circular clássica não está presente em todos os casos.

MALASSEZIA

Leveduras oportunistas podem crescer em pele e ouvido inflamados.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Citologia quantifica achado no contexto da



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Investigue alergia, umidade e outras causas

03 LIMITE

Presença isolada de levedura não define

01

ENTENDA

Citologia quantifica achado no contexto da lesão.

02

NA PRÁTICA

Investigue alergia, umidade e outras causas predisponentes.

ATENÇÃO CLÍNICA

Presença isolada de levedura não define a causa primária.

INFECÇÃO URINÁRIA

Sinais urinários baixos têm causas infecciosas e não infecciosas.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Urina coletada adequadamente e cultura ajudam



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Relacione crescimento bacteriano a sintomas e

03 LIMITE

Bacteriúria assintomática não deve ser tratada

01

ENTENDA

Urina coletada adequadamente e cultura ajudam em casos selecionados.

02

NA PRÁTICA

Relacione crescimento bacteriano a sintomas e sedimento.

ATENÇÃO CLÍNICA

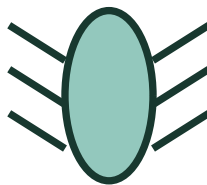
Bacteriúria assintomática não deve ser tratada automaticamente.

EXAME COPROPARASITOLÓGICO

Um resultado depende da técnica, da amostra e da eliminação do parasita.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Flutuação centrífuga detecta muitos ovos e

02 APLICAÇÃO

Testes de antígeno ou PCR complementam

03 LIMITE

Exame negativo único não exclui toda

01

ENTENDA

Flutuação centrífuga detecta muitos ovos e oocistos.

02

NA PRÁTICA

Testes de antígeno ou PCR complementam casos selecionados.

ATENÇÃO CLÍNICA

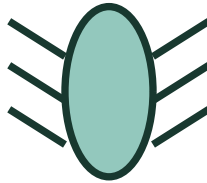
Exame negativo único não exclui toda parasitose.

GIARDIA

Giardíase pode cursar com fezes moles e eliminação intermitente.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Considere histórico, testes adequados e higiene

02 APLICAÇÃO

Avalie outras causas de diarreia em

03 LIMITE

Teste positivo pede correlação clínica

01

ENTENDA

Considere histórico, testes adequados e higiene ambiental.

02

NA PRÁTICA

Avalie outras causas de diarreia em paralelo.

ATENÇÃO CLÍNICA

Teste positivo pede correlação clínica.

COCCÍDIOS

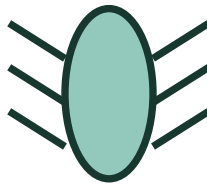
Oocistos e contexto ajudam a diferenciar infecção de achado incidental.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Filhotes e ambientes coletivos merecem atenção



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Interprete carga, sinais e exame fecal

03 LIMITE

Identificação microscópica deve ser cuidadosa

01

ENTENDA

Filhotes e ambientes coletivos merecem atenção.

02

NA PRÁTICA

Interprete carga, sinais e exame fecal.

ATENÇÃO CLÍNICA

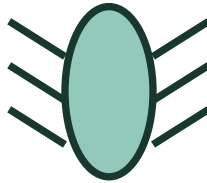
Identificação microscópica deve ser cuidadosa.

TOXOCARA

Ascarídeos têm importância para saúde animal e humana.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Histórico de vermifugação e acesso ao

02 APLICAÇÃO

Prevenção envolve higiene e plano antiparasitário

03 LIMITE

Ovos podem não aparecer em fase

01

ENTENDA

Histórico de vermifugação e acesso ao ambiente orientam risco.

02

NA PRÁTICA

Prevenção envolve higiene e plano antiparasitário individual.

ATENÇÃO CLÍNICA

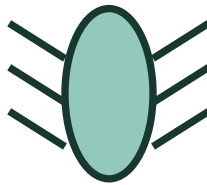
Ovos podem não aparecer em fase pré-patente.

ANCYLOSTOMA

Ancilostomídeos podem provocar perda sanguínea e enteropatia.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Filhotes com anemia e diarreia exigem

02 APLICAÇÃO

Exame fecal e prevenção ambiental fazem

03 LIMITE

Gravidade não é estimada apenas pela

01

ENTENDA

Filhotes com anemia e diarreia exigem avaliação rápida.

02

NA PRÁTICA

Exame fecal e prevenção ambiental fazem parte do controle.

ATENÇÃO CLÍNICA

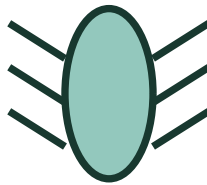
Gravidade não é estimada apenas pela contagem de ovos.

PULGAS

Além da coceira, pulgas podem sustentar alergia e outros parasitas.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Procure fezes de pulga e padrão

02 APLICAÇÃO

Controle inclui todos os animais e

03 LIMITE

Não ver pulgas no exame não

01

ENTENDA

Procure fezes de pulga e padrão de distribuição das lesões.

02

NA PRÁTICA

Controle inclui todos os animais e ambiente quando indicado.

ATENÇÃO CLÍNICA

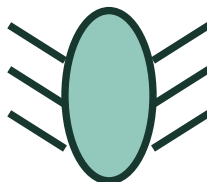
Não ver pulgas no exame não exclui infestação.

CARRAPATOS

A exposição aumenta risco de doenças transmitidas por vetores.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Examine pele, histórico de viagem e

02 APLICAÇÃO

Testes são guiados por sinais e

03 LIMITE

Resultado positivo pode significar exposição, não

01

ENTENDA

Examine pele, histórico de viagem e prevenção usada.

02

NA PRÁTICA

Testes são guiados por sinais e epidemiologia.

ATENÇÃO CLÍNICA

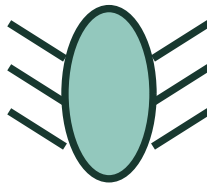
Resultado positivo pode significar exposição, não doença ativa.

SARNA SARCÓPTICA

Prurido intenso e contato com outros animais ajudam na suspeita.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Raspado pode não encontrar o ácaro

02 APLICAÇÃO

Considere contagiosidade e manejo dos contatos

03 LIMITE

Ausência de ácaro no raspado não

01

ENTENDA

Raspado pode não encontrar o ácaro em todos os casos.

02

NA PRÁTICA

Considere contagiosidade e manejo dos contatos.

ATENÇÃO CLÍNICA

Ausência de ácaro no raspado não exclui totalmente o quadro.

DEMODICOSE

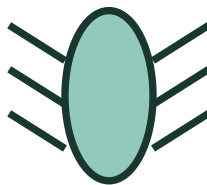
A proliferação de ácaros Demodex pode causar alopecia e inflamação.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Exames de pele sustentam o diagnóstico



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Investigue infecção secundária e fatores predisponentes

03 LIMITE

Nem toda alopecia focal é demodicose

01

ENTENDA

Exames de pele sustentam o diagnóstico.

02

NA PRÁTICA

Investigue infecção secundária e fatores predisponentes.

ATENÇÃO CLÍNICA

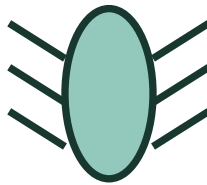
Nem toda alopecia focal é demodicose.

VERMES CARDÍACOS

Dirofilariose depende da transmissão por mosquito e da região.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Prevenção e testes seguem risco local

02 APLICAÇÃO

Cães e gatos podem apresentar quadros

03 LIMITE

Um mesmo teste não detecta todas

01

ENTENDA

Prevenção e testes seguem risco local e espécie.

02

NA PRÁTICA

Cães e gatos podem apresentar quadros diferentes.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um mesmo teste não detecta todas as fases ou apresentações.

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS

AINEs reduzem mediadores inflamatórios, mas exigem seleção cuidadosa.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Avalie hidratação, rim, trato gastrointestinal e



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Reavalie vômito, inapetência, melena e comportamento

03 LIMITE

Nunca combine AINEs ou AINE e

01

ENTENDA

Avalie hidratação, rim, trato gastrointestinal e outros fármacos.

02

NA PRÁTICA

Reavalie vômito, inapetência, melena e comportamento.

ATENÇÃO CLÍNICA

Nunca combine AINEs ou AINE e corticoide sem avaliação específica.

GLICOCORTICOIDES

Corticoides modulam inflamação e imunidade por vários mecanismos.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Indicação, duração e acompanhamento dependem do



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Observe efeitos metabólicos e risco de

03 LIMITE

Suspensão abrupta após uso prolongado pode

01

ENTENDA

Indicação, duração e acompanhamento dependem do problema.

02

NA PRÁTICA

Observe efeitos metabólicos e risco de infecção.

ATENÇÃO CLÍNICA

Suspensão abrupta após uso prolongado pode ser inadequada.

OPIOIDES

Opioides são ferramentas importantes para dor aguda e perioperatória.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Escolha depende da intensidade da dor



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Avalie sedação, ventilação e resposta analgésica

03 LIMITE

Sedação não é sinônimo de analgesia

01

ENTENDA

Escolha depende da intensidade da dor e monitoramento disponível.

02

NA PRÁTICA

Avalie sedação, ventilação e resposta analgésica.

ATENÇÃO CLÍNICA

Sedação não é sinônimo de analgesia suficiente.

ANESTÉSICOS LOCAIS

Bloqueios podem reduzir transmissão periférica da dor.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Técnica e dose total precisam considerar



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Aspiração e anatomia ajudam a prevenir

03 LIMITE

Toxicidade sistêmica pode ser grave

01

ENTENDA

Técnica e dose total precisam considerar local e paciente.

02

NA PRÁTICA

Aspiração e anatomia ajudam a prevenir aplicação intravascular.

ATENÇÃO CLÍNICA

Toxicidade sistêmica pode ser grave.

SEDATIVOS

Sedação diminui reatividade, mas não substitui analgesia ou anestesia.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Considere temperamento, doença cardiovascular e procedimento



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Monitore oxigenação, perfusão e recuperação

03 LIMITE

Paciente calmo ainda pode sentir dor

01

ENTENDA

Considere temperamento, doença cardiovascular e procedimento.

02

NA PRÁTICA

Monitore oxigenação, perfusão e recuperação.

ATENÇÃO CLÍNICA

Paciente calmo ainda pode sentir dor.

ANTIEMÉTICOS

Controlar vômito melhora conforto, mas não resolve a causa.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Considere obstrução, toxinas, distúrbios metabólicos e



02 APLICAÇÃO

Escolha o alvo farmacológico conforme hipótese

RELACIONAR

03 LIMITE

Mascarar vômito sem investigar sinais de

01

ENTENDA

Considere obstrução, toxinas, distúrbios metabólicos e vestibulares.

02

NA PRÁTICA

Escolha o alvo farmacológico conforme hipótese clínica.

ATENÇÃO CLÍNICA

Mascarar vômito sem investigar sinais de alarme atrasa diagnóstico.

DIURÉTICOS

Diuréticos mudam excreção de água e eletrólitos.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Avalie congestão, volemia, rim e resposta



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Monitore hidratação, peso e eletrólitos

03 LIMITE

Mais urina não significa melhora da

01

ENTENDA

Avalie congestão, volemia, rim e resposta clínica.

02

NA PRÁTICA

Monitore hidratação, peso e eletrólitos.

ATENÇÃO CLÍNICA

Mais urina não significa melhora da perfusão.

ANTIPARASITÁRIOS

Eficácia depende do agente, espécie, formulação e esquema.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Identifique o parasita ou o risco



02 APLICAÇÃO

Confira idade, peso e restrições do

RELACIONAR

03 LIMITE

Produtos para cães podem ser perigosos

01

ENTENDA

Identifique o parasita ou o risco antes da escolha.

02

NA PRÁTICA

Confira idade, peso e restrições do produto.

ATENÇÃO CLÍNICA

Produtos para cães podem ser perigosos para gatos.

FÁRMACOS EM GATOS

Diferenças fisiológicas e metabólicas exigem prescrição própria.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Considere comportamento de administração e risco



02 APLICAÇÃO

Cheque aprovação, concentração e excipientes específicos

RELACIONAR

03 LIMITE

Nunca extrapole uma prescrição canina por

01

ENTENDA

Considere comportamento de administração e risco de estresse.

02

NA PRÁTICA

Cheque aprovação, concentração e excipientes específicos.

ATENÇÃO CLÍNICA

Nunca extrapole uma prescrição canina por proporção simples.

VÔMITO VERSUS REGURGITAÇÃO

Distinguir os mecanismos direciona a investigação.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Vômito envolve esforço abdominal; regurgitação costuma

02 APLICAÇÃO

Pergunte quando ocorre em relação à

03 LIMITE

O tutor pode chamar ambos de

01

ENTENDA

Vômito envolve esforço abdominal; regurgitação costuma ser passiva.

02

NA PRÁTICA

Pergunte quando ocorre em relação à alimentação.

ATENÇÃO CLÍNICA

O tutor pode chamar ambos de vômito.

DIARREIA DE INTESTINO DELGADO

Volume maior e perda de peso podem sugerir intestino delgado.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Avalie duração, dieta, parasitas e estado

02 APLICAÇÃO

Sinais sistêmicos mudam urgência e testes

03 LIMITE

Não atribua toda diarreia a parasitas

01

ENTENDA

Avalie duração, dieta, parasitas e estado geral.

02

NA PRÁTICA

Sinais sistêmicos mudam urgência e testes.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não atribua toda diarreia a parasitas.

DIARREIA DE INTESTINO GROSSO

Tenesmo, muco e evacuações frequentes orientam o padrão.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Compare com apetite, hidratação e presença



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Padrões mistos também acontecem

03 LIMITE

Sangue fresco não indica automaticamente gravidade

01

ENTENDA

Compare com apetite, hidratação e presença de sangue.

02

NA PRÁTICA

Padrões mistos também acontecem.

ATENÇÃO CLÍNICA

Sangue fresco não indica automaticamente gravidade menor.

DOENÇA RENAL CRÔNICA

A interpretação exige persistência e contexto do paciente.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Combine função, urina, pressão e tendências

02 APLICAÇÃO

Estadiamento segue recomendações atualizadas

03 LIMITE

Um exame alterado durante desidratação não

01

ENTENDA

Combine função, urina, pressão e tendências laboratoriais.

02

NA PRÁTICA

Estadiamento segue recomendações atualizadas.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um exame alterado durante desidratação não define cronicidade.

OBSTRUÇÃO URETRAL FELINA

Gato que tenta urinar sem conseguir é emergência.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Palpe com cuidado, avalie perfusão e

02 APLICAÇÃO

Desobstrução e estabilização exigem equipe veterinária

03 LIMITE

Não confunda esforço urinário com constipação

01

ENTENDA

Palpe com cuidado, avalie perfusão e eletrólitos.

02

NA PRÁTICA

Desobstrução e estabilização exigem equipe veterinária.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não confunda esforço urinário com constipação.

DIABETES MELLITUS

Poliúria, polidipsia e perda de peso formam um padrão comum.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Confirme hiperglicemia persistente com achados clínicos



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Gatos podem ter hiperglicemia transitória por

03 LIMITE

Uma glicemia elevada isolada não basta

01

ENTENDA

Confirme hiperglicemia persistente com achados clínicos e urina.

02

NA PRÁTICA

Gatos podem ter hiperglicemia transitória por estresse.

ATENÇÃO CLÍNICA

Uma glicemia elevada isolada não basta.

HIPERADRENOCORTICISMO CANINO

Sinais são graduais e podem ser inespecíficos.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Observe poliúria, polidipsia, alterações cutâneas e



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Escolha testes endócrinos após estabelecer suspeita

03 LIMITE

Exame de triagem não deve substituir

01

ENTENDA

Observe poliúria, polidipsia, alterações cutâneas e abdome.

02

NA PRÁTICA

Escolha testes endócrinos após estabelecer suspeita clínica.

ATENÇÃO CLÍNICA

Exame de triagem não deve substituir história e exame.

HIPERTIREOIDISMO FELINO

Perda de peso com apetite preservado ou aumentado é uma pista.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Associe exame físico, pressão e dosagem

02 APLICAÇÃO

Doença concomitante pode influenciar a interpretação

03 LIMITE

Valor limítrofe pode exigir reavaliação

01

ENTENDA

Associe exame físico, pressão e dosagem hormonal.

02

NA PRÁTICA

Doença concomitante pode influenciar a interpretação.

ATENÇÃO CLÍNICA

Valor limítrofe pode exigir reavaliação.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA

Congestão deve ser diferenciada de outras causas de dispneia.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Observe esforço, frequência em repouso e



02 APLICAÇÃO

Imagem e ecocardiografia esclarecem estrutura e

RELACIONAR

03 LIMITE

Sopro não é sinônimo de insuficiência

01

ENTENDA

Observe esforço, frequência em repouso e exame torácico.

02

NA PRÁTICA

Imagem e ecocardiografia esclarecem estrutura e repercussão.

ATENÇÃO CLÍNICA

Sopro não é sinônimo de insuficiência cardíaca.

CONVULSÃO

Descreva episódio, duração e estado antes e depois.

MAPA VISUAL

OBSERVAR



RELACIONAR

01 CONCEITO

Priorize segurança, glicose e causas metabólicas

02 APLICAÇÃO

Vídeo do tutor pode melhorar a

03 LIMITE

Síncope e alterações de movimento podem

01

ENTENDA

Priorize segurança, glicose e causas metabólicas possíveis.

02

NA PRÁTICA

Vídeo do tutor pode melhorar a caracterização.

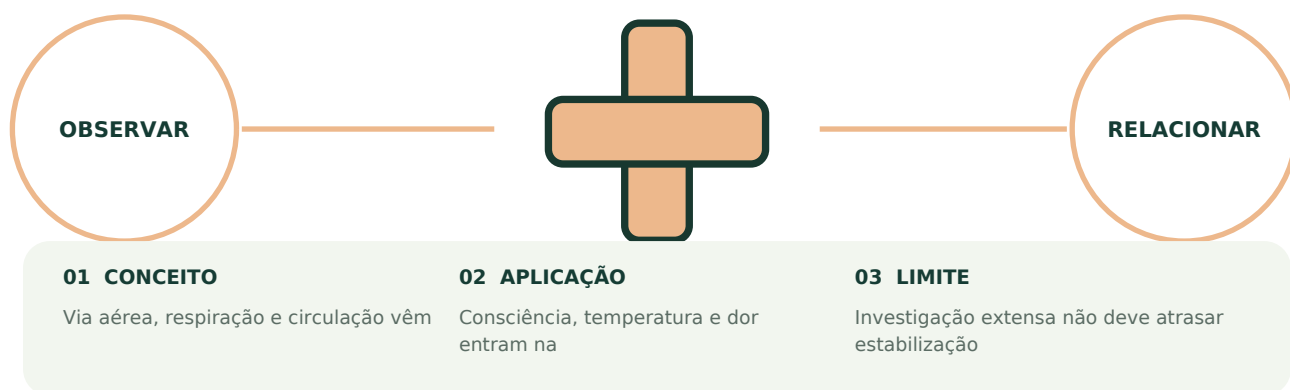
ATENÇÃO CLÍNICA

Síncope e alterações de movimento podem imitar convulsão.

ABCDE NA EMERGÊNCIA

A avaliação primária procura ameaças tratáveis em minutos.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Via aérea, respiração e circulação vêm primeiro.

02

NA PRÁTICA

Consciência, temperatura e dor entram na reavaliação contínua.

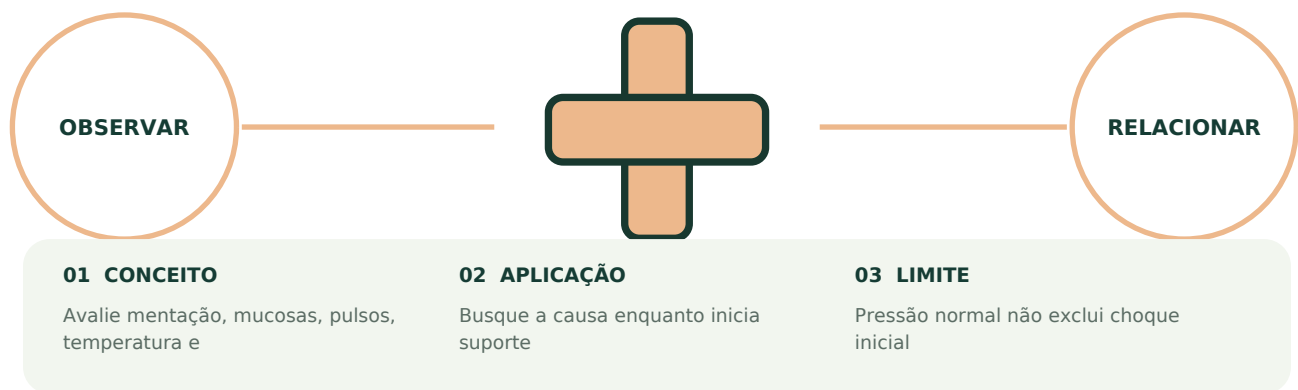
ATENÇÃO CLÍNICA

Investigação extensa não deve atrasar estabilização.

CHOQUE: RECONHECIMENTO

Choque é perfusão tecidual inadequada por mecanismos distintos.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Avalie mentação, mucosas, pulsos, temperatura e pressão.

02

NA PRÁTICA

Busque a causa enquanto inicia suporte apropriado.

ATENÇÃO CLÍNICA

Pressão normal não exclui choque inicial.

DISPNEIA: MANUSEIO MÍNIMO

Pacientes dispneicos podem piorar com contenção excessiva.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Observe à distância, ofereça ambiente calmo e oxigênio quando indicado.

02

NA PRÁTICA

Faça exames invasivos após considerar estabilidade.

ATENÇÃO CLÍNICA

Decúbito forçado pode precipitar descompensação.

HEMORRAGIA AGUDA

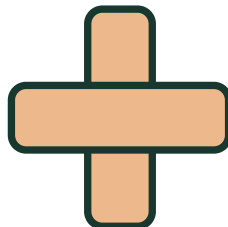
Controle de perda e avaliação de perfusão são prioridades.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Compressão local pode ajudar em sangramento



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Monitore resposta e considere fonte interna

03 LIMITE

Hematócrito inicial pode ser enganoso na

01

ENTENDA

Compressão local pode ajudar em sangramento externo.

02

NA PRÁTICA

Monitore resposta e considere fonte interna.

ATENÇÃO CLÍNICA

Hematócrito inicial pode ser enganoso na fase aguda.

INTOXICAÇÃO SUSPEITA

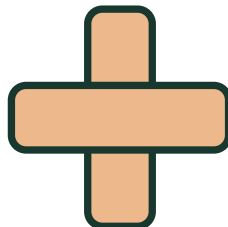
Produto, dose, via e horário são dados críticos.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Guarde embalagem e registre sinais já



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Contato rápido com equipe veterinária
orienta

03 LIMITE

Induzir vômito em casa pode ser

01

ENTENDA

Guarde embalagem e registre sinais já observados.

02

NA PRÁTICA

Contato rápido com equipe veterinária orienta medidas seguras.

ATENÇÃO CLÍNICA

Induzir vômito em casa pode ser perigoso.

HIPERTERMIA

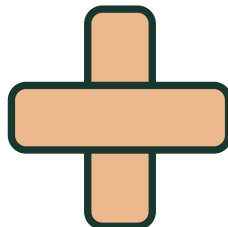
Temperatura alta e sinais neurológicos podem acompanhar insolação.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Resfriamento controlado e avaliação sistêmica são



02 APLICAÇÃO

Monitore temperatura e complicações após a

RELACIONAR

03 LIMITE

Queda exagerada da temperatura também causa

01

ENTENDA

Resfriamento controlado e avaliação sistêmica são urgentes.

02

NA PRÁTICA

Monitore temperatura e complicações após a melhora inicial.

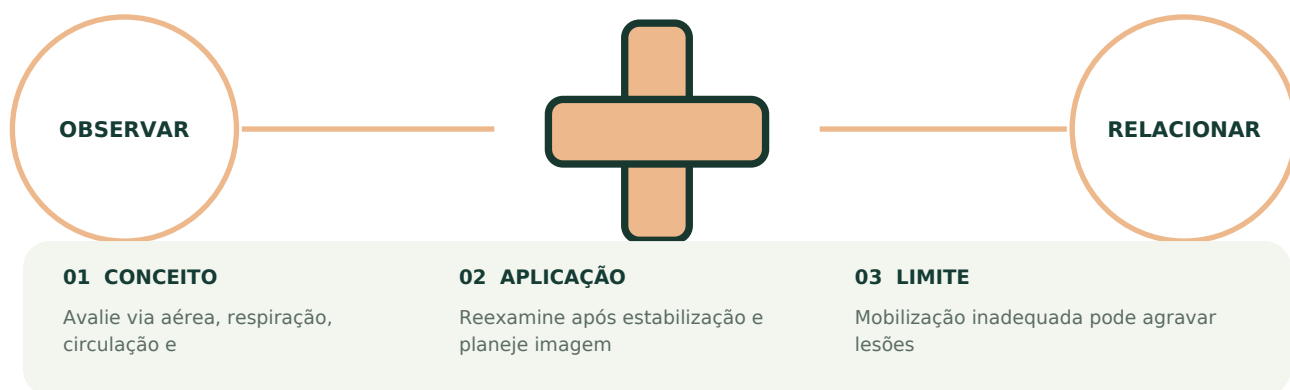
ATENÇÃO CLÍNICA

Queda exagerada da temperatura também causa dano.

TRAUMA

A lesão visível pode esconder problemas internos mais graves.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Avalie via aérea, respiração, circulação e dor.

02

NA PRÁTICA

Reexamine após estabilização e planeje imagem.

ATENÇÃO CLÍNICA

Mobilização inadequada pode agravar lesões.

FLUIDOTERAPIA INDIVIDUALIZADA

Fluidos são medicamentos com indicação e alvo de resposta.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Separe reposição, manutenção e perdas contínuas.

02

NA PRÁTICA

Reavalie perfusão, peso, débito e sinais de sobrecarga.

ATENÇÃO CLÍNICA

Volume padrão para todos os pacientes não é seguro.

ANESTESIA: ANTES, DURANTE, DEPOIS

O risco anestésico se gerencia como processo contínuo.

MAPA VISUAL

**01**

ENTENDA

Prepare avaliação, acesso, equipamento e plano de analgesia.

02

NA PRÁTICA

Monitore ventilação, oxigenação, perfusão e recuperação.

ATENÇÃO CLÍNICA

A recuperação também exige vigilância.

REANIMAÇÃO E EQUIPE

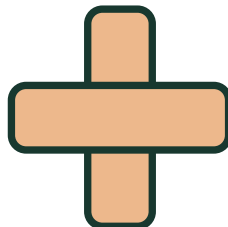
Papéis definidos ajudam a executar manobras em emergência.

MAPA VISUAL

OBSERVAR

01 CONCEITO

Reconheça parada, peça ajuda e siga



RELACIONAR

02 APLICAÇÃO

Registre tempos, intervenções e resposta

03 LIMITE

Treino prévio melhora coordenação sob pressão

01

ENTENDA

Reconheça parada, peça ajuda e siga protocolo institucional.

02

NA PRÁTICA

Registre tempos, intervenções e resposta.

ATENÇÃO CLÍNICA

Treino prévio melhora coordenação sob pressão.

VACINAS ESSENCIAIS

Vacinação protege contra doenças de grande relevância coletiva.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Plano depende de espécie, idade, histórico e risco local.

02

NA PRÁTICA

Registre produto, data, lote e reações.

ATENÇÃO CLÍNICA

Um calendário genérico não atende todo paciente.

VACINAS NÃO ESSENCIAIS

Exposição ambiental e estilo de vida orientam indicação.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Revise viagens, contato com outros animais e circulação regional.

02

NA PRÁTICA

Converse com tutor sobre benefício e riscos.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não confunda opcional com desnecessária para todos.

CONTROLE DE ENDOPARASITAS

Prevenção combina avaliação de risco e exames apropriados.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Filhotes e animais com acesso externo demandam atenção particular.

02

NA PRÁTICA

Plano deve considerar espécie e epidemiologia local.

ATENÇÃO CLÍNICA

Vermifugar às cegas indefinidamente não substitui diagnóstico.

CONTROLE DE ECTOPARASITAS

Pulgas e carrapatos impactam pele e doenças vetoriais.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Escolha produto adequado ao animal e à exposição.

02

NA PRÁTICA

Trate ambiente e conviventes quando necessário.

ATENÇÃO CLÍNICA

Leia restrições de espécie antes da aplicação.

NUTRIÇÃO E ESCORE CORPORAL

Avaliação nutricional faz parte de cada consulta.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Registre dieta, quantidade, petiscos e escore corporal.

02

NA PRÁTICA

Ajustes devem considerar fase de vida e doenças.

ATENÇÃO CLÍNICA

Marca ou rótulo isolado não substitui avaliação nutricional.

SAÚDE BUCAL

Doença periodontal pode causar dor sem queixa clara do tutor.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Inspeção de cavidade oral e acompanhamento de halitose e gengivas.

02

NA PRÁTICA

Planeje avaliação profissional e prevenção domiciliar.

ATENÇÃO CLÍNICA

Não raspe tártaro sem avaliação de estruturas subgengivais.

ZOONOSES E HIGIENE

Saúde animal, humana e ambiental estão conectadas.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Oriente lavagem de mãos, recolhimento de fezes e controle de vetores.

02

NA PRÁTICA

Reforce cuidado para crianças e pessoas imunossuprimidas.

ATENÇÃO CLÍNICA

Medo de zoonose não deve substituir orientação baseada em risco.

COMUNICAÇÃO COM O TUTOR

Uma orientação compreendida aumenta adesão e segurança.

MAPA VISUAL



01

ENTENDA

Explique hipótese, próximos passos e sinais de retorno.

02

NA PRÁTICA

Peça ao tutor que repita como administrará a medicação.

ATENÇÃO CLÍNICA

Termos técnicos sem tradução podem gerar erros em casa.

FONTES E USO RESPONSÁVEL

Este atlas é um apoio visual para estudo e revisão. Cada ficha resume um conceito; os links abaixo levam às fontes técnicas para aprofundamento e atualização.

1

Merck Veterinary Manual, Pharmacokinetics / Pharmacodynamics

2

Merck, Initial Triage and Resuscitation of Small Animal Emergency Patients

3

Merck, Clinical Hematology / Leukogram Abnormalities

4

Merck, Urinalysis

5

ISCAID, Guidelines / Merck, Otitis Externa

6

CAPC, General Guidelines for Dogs and Cats

7

Merck, Analgesics Used in Animals / AAHA, Anesthesia

8

Merck Veterinary Manual, Small Animal Clinical Topics

9

AAHA, 2024 Fluid Therapy / 2020 Anesthesia Guidelines

10

WSAVA, Global Guidelines: Vaccination, Nutrition and Pain

Fontes consultadas em setembro de 2026. Diretrizes, produtos e indicações mudam. Antes de aplicar uma conduta, verifique a fonte atual, a legislação local e as características do paciente.